

Lettera di Dimissione Ospedaliera

Generato il: 11 maggio 2026

PAZIENTE

Mario Rossi

Nato/a il: 01/01/1980 a Roma (RM)

CF: RSSMRA80A01H501U

SPECIALISTA

Dr. Simone Bianchi - OSPEDALE TEST FSE**Data ricovero:** 2024-03-17**Data dimissione:** 2024-04-17**Nosologico:** 2024-TC451-0001**Reparto:** Cardiologia**MOTIVO DEL RICOVERO**

Disturbo di panico con ipertiroidismo

Codice ICD9: 300.01 — Disturbo di panico**INQUADRAMENTO CLINICO INIZIALE**

Paziente proveniente da Pronto Soccorso. Quadro di infiammazione cronica delle vie aeree e del tessuto polmonare con limitazione del flusso aereo.

ANAMNESI

Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico dal 2010. Appendicectomia ottobre 2021. Cordotomia percutanea febbraio 2011. Familiarità per cardiopatia ischemica.

ESAME OBIETTIVO

Condizioni generali: paziente vigile, orientato e collaborante. Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica normofrequente, toni puri e pause libere. PA 160/95 mmHg, FC 110 bpm. Edemi declivi presenti.

TERAPIA FARMACOLOGICA ALL'INGRESSO

Furosemide 40 mg ev in bolo. Ramipril 5 mg per os 1 cp/die. Cardicor 5 mg per os 1 cp/die. Peptazol 40 mg per os 1 cp/die.

ALLERGIE

Sostanza	Tipo	Reazione	Gravità
Amoxicillina	Allergia	Orticaria	Moderata

DECORSO OSPEDALIERO

Il paziente giungeva alla nostra attenzione sintomatico per scompenso cardiaco acuto. Durante il ricovero è stato ottenuto un ripristino dello stato di compenso emodinamico mediante trattamento farmacologico intensivo.

RISCONTRI ED ACCERTAMENTI SIGNIFICATIVI

Ecocardiogramma: frazione di eiezione 35%. RX torace: congestione polmonare lieve. Esami ematici nei limiti tranne BNP 850 pg/mL.

CONDIZIONI ALLA DIMISSIONE E DIAGNOSI

Paziente in cattivo compenso emodinamico per insufficienza della valvola aortica di grado severo. Non in grado di deambulare correttamente.

Codice ICD9: 428.0 — Insufficienza cardiaca

TERAPIA FARMACOLOGICA ALLA DIMISSIONE

Farmaco	ATC/AIC	Posologia	Dose
Ramipril 5 mg	C09AA05	1 cp ore 8	5 mg
Furosemide 25 mg	C03CA01	1 cp ore 8 (per 7 giorni)	25 mg

ISTRUZIONI DI FOLLOW-UP

Controllo cardiologico tra 30 giorni con ecocardiogramma di controllo. Dieta iposodica. Monitoraggio quotidiano del peso e della pressione arteriosa. Contattare immediatamente il medico curante in caso di dispnea a riposo, edemi ingravescenti o aumento del peso > 2 kg in 3 giorni.

Dr. Simone Bianchi - OSPEDALE TEST FSE

Allegato CDA2 HL7 incluso nel presente PDF (cda.xml)